BONUS 2

50 nejčastějších chyb v popisu, které opravuje školitel

50 chyb, kvůli kterým se popisy vracejí; každá ve struktuře „Původní text → Správně → Důvod“. Opravte si vlastní popis dříve, než se setkáte s červenou propiskou svého školitele.

Obsah

Jak tento seznam používat

Technika a porovnání — 6 chyb

Terminologie — 7 chyb

Lokalizace, strana a rozměr — 8 chyb

Nález – 9 chyb

Závěr — 8 chyb

Doporučení — 4 chyby

Urgentní nález a hlášení – 4 chyby

Formální úprava a před podpisem – 4 chyby

Další krok

ÚVODEM

Jak tento seznam používat

Chyby jsou rozděleny podle 4krokové metody: PŘIPRAVTE, PROJDĚTE, POPIŠTE, SHRŇTE.

> *Většina chyb v popisu nepramení z nedostatku znalostí, ale ze zvyku. A zvyk se po uvědomění snadno napraví.*

KROK V METODĚ	PŘÍSLUŠNÉ SKUPINY CHYB
PŘIPRAVTE	Technika a porovnání
PROJDĚTE	Nález (opomenutí a významné negativní nálezy)
POPIŠTE	Terminologie · Lokalizace, strana a rozměr · Nálezy
SHRŇTE	Závěr · Doporučení · Akutní nález a hlášení · Formát a kontrola před podpisem

1. **Po dobu jednoho týdne si každý den projděte jednu skupinu.** Osm skupin, osm dní.
2. **Každý popis opravený vaším školitelem porovnejte s tímto seznamem.** Pokud se stejná chyba opakuje dvakrát, přidejte si ji do kontrolního seznamu.
3. **Před podpisem použijte Jednostránkový kontrolní seznam popisu.** Položky na seznamu jsou shrnutím těchto 50 chyb.

Zvyklost pracoviště

Pokud se formát popisu nebo preferovaná terminologie vašeho pracoviště liší od zde uvedených příkladů, platí pravidla vašeho pracoviště. Hlavním cílem je osvojit si princip: jasný, věcný, srovnávací popis odpovídající na klinickou otázku.

SKUPINA 1

Technika a porovnání

6 chyb · Napsáno → Správně → Důvod

Č.	ZAPSÁNO	SPRÁVNĚ	DŮVOD
01	Pole techniky zůstalo prázdné.	«Nativní CT mozku; axiální řezy hodnoceny v mozkovém a kostním okně.»	*Čtenář nemůže posoudit spolehlivost nálezů, aniž by věděl, jaké vyšetření a za jakých podmínek bylo hodnoceno.*
02	«CT břicha s i.v. kontrastem.»	«CT břicha a pánve s i.v. kontrastem, portální žilní fáze.»	*Fáze určuje, zda bude nález viditelný; bez informací z arteriální fáze nelze hodnotit aktivní krvácení.*
03	Neuvedena technická limitace (pohybové artefakty, nedostatečný nádech).	«Hodnocení zadní jámy je limitováno pohybovými artefakty.»	*Pokud není uvedena limitace, věta „bez nálezu“ vyznívá důvěryhodněji, než jaká je realita.*
04	«Porovnáno s předchozím vyšetřením.»	«[Datum] porovnáno s CT hrudníku ze dne.»	*Bez data a modality nelze ověřit, se kterým vyšetřením bylo porovnáváno.*
05	Ačkoli bylo k dispozici předchozí vyšetření, nebylo provedeno porovnání.	«Velikost uzlu oproti předchozímu vyšetření [.. mm] od [.. mm] se zvýšil na».	*Hlavní otázkou kontrolního vyšetření bývá obvykle vývoj; bez porovnání popis na tuto otázku neodpovídá.*
06	«Porovnání: není.»	«Předchozí vyšetření k porovnání není k dispozici.»	*«Není» je nejednoznačné: není v systému, nebo se na to nikdo nepodíval? Jednoznačná věta tuto pochybnost odstraní.*

SKUPINA 2

Terminologie

7 chyb · Napsáno → Správně → Důvod

Č.	ZAPSÁNO	SPRÁVNĚ	DŮVOD
07	U CT „hyperintenzní léze“.	U CT „hyperdenzní léze“.	*U CT se používá denzita, u MR signál, u UZ echogenita; nesprávný termín vyvolává dojem, že danou modalitu neznáte.*
08	Na UZ „hypodenzní útvar“.	Na UZ „hypoechogenní útvar“.	*Echogenita je termín specifický pro UZ.*
09	U cysty „hypoechogenní“.	U prosté cysty „anechogenní“.	*Anechogenní a hypoechogenní znamenají odlišný obsah; diagnóza prosté cysty se opírá o tento rozdíl.*
10	«Byl patrný tumor.»	«[.. mm] byla patrná expanze.»	*Nádor je histologická diagnóza; zobrazovací nález se definuje jako útvar nebo léze.*
11	«Infiltrace» (pro každou opacitu na snímku).	Popisný termín jako «konsolidace», «mléčné sklo», «retikulární opacita».	*«Infiltrace» je nejednoznačný pojem a pro různé lékaře znamená různé věci.*
12	«Přítomen expanzivní efekt.»	«Vyhlazení sulků, komprese ipsilaterální komory a [.. mm] přetlačení středočárových struktur.»	*Stupeň expanzivního chování musí být uveden s rozměry a nálezy; klinické rozhodování se podle toho mění.*
13	«V normě» (pro všechno).	Uveďte příslušné orgány stručně jeden po druhém: «Játra, slezina i ledviny v normě.»	*Zůstává nejasné, co bylo hodnoceno; čtenář nepozná opomenutý orgán.*

SKUPINA 3

Lokalizace, strana a rozměr

8 chyb · Napsáno → Správně → Důvod

Č.	ZAPSÁNO	SPRÁVNĚ	DŮVOD
14	Není uvedena strana: „Pleurální výpotek.“	«Pleurální výpotek vpravo.»	*Neuvedení strany může vést k závažné chybě při výkonech, jako je torakocentéza nebo operace.*
15	Špatná strana ponechaná ze šablony.	Strana se ještě jednou zkontroluje podle značky na snímku a žádanky.	*Je to nejnebezpečnější z chyb při kopírování a vkládání; strana v Nálezech a Závěru se musí shodovat.*
16	«Léze v levé plíci.»	«Léze v apikálním segmentu levého dolního laloku.»	*Údaj o laloku a segmentu je nezbytný jak při sledování, tak při plánování bronchoskopie či biopsie.*
17	«Velká expanze», «malý uzel».	«[.. x .. mm] expanze», «[.. mm] uzel».	*Přídavná jména nejsou rozměr; změnu při sledování lze hodnotit pouze pomocí čísel.*
18	Změřen pouze jeden rozměr, není uvedena rovina.	«V axiální rovině [.. x .. mm], kraniokaudální [.. mm].»	*Měření provedené v jiné rovině vyvolává při sledování falešný dojem progrese nebo regrese.*
19	U rozměru chybí jednotka: «Nodul 8.»	«Uzel [.. mm].»	*Číslo bez jednotky může být špatně interpretováno a je medicínsko-právně neobhajitelné.*
20	U jaterní léze: „v pravém laloku“.	«Segment [..] v».	*Údaj o segmentu je standardem pro chirurgické a intervenční plánování.*
21	U fraktury žebra chybí číslo.	«Vpravo [..]. žebra v laterálním oblouku.»	*Určení konkrétního zlomeného žebra je nezbytné pro sledování a korelaci s klinickým vyšetřením.*

SKUPINA 4

Nález

9 chyb · Napsáno → Správně → Důvod

Č.	ZAPSÁNO	SPRÁVNĚ	DŮVOD
22	Pozornost se zastavila u prvního nálezu; druhý nález byl přehlédnut.	Každá oblast se prochází pokaždé ve stejném pořadí; uvede se i druhý nález.	*«Uspokojení z nálezu» (satisfaction of search) je nejčastější příčinou přehlédnutí další patologie.*
23	Není uveden významný negativní nález (u otázky na apendicitidu chybí zmínka o apendixu).	«Apendix normálního vzhledu; známky akutní apendicitidy nezastiženy.»	*Pokud není uveden orgán, jehož se klinická otázka týká, klinik nemůže vědět, zda byl hodnocen.*
24	U otázky na krvácení chybí zmínka o kostním okně.	«V kostním okně bez fraktury kalvy.»	*Hodnocení fraktur na traumatickém CT vyžaduje kostní okno; pokud to není uvedeno, předpokládá se, že nebylo hodnoceno.*
25	Nález je smíchán s interpretací: „Zastižena pneumonie.“	V Nálezu: „Konsolidace se vzdušným bronchogramem.“ V Závěru: „Může odpovídat pneumonii.“	*Nález obsahuje pozorování, Závěr interpretaci; pokud se smíchají, popis se stává těžko obhajitelným.*
26	Není zmínka o tubusech a katétrech.	«Konec ETT nad karinou **[.. cm]** nad ním; hrot CŽK v projekci horní duté žíly.»	*Nejčastější klinickou otázkou u snímků z JIP je poloha zavedených vstupů a kanyl.*
27	Ostatní struktury v zorném poli byly opomenuty (horní část břicha na CT hrudníku).	«V zobrazených řezech horního břicha **[bez patologie/..]**.»	*Za každou strukturu v zorném poli odpovídá popisující lékař; léze nadledvin nebo jater bývají často přehlédnuty.*
28	Stejný nález se v Nálezu třikrát opakuje.	Každý nález se uvádí pouze jednou, pod příslušným orgánem.	*Opakování popis prodlužuje a ztěžuje čtenáři nalezení klíčového nálezu.*
29	Kostní léze bez bližšího určení: „Léze v kosti.“	«**[Kost]** v **[.. mm]**, **[lytická/sklerotická]**, **[úzká/široká]** léze s přechodovou zónou; periostální reakce **[není/je]**.»	*Charakter kostní léze (přechodová zóna, matrix, periost) určuje diferenciální diagnózu.*
30	U tekutinové kolekce není uveden obsah ani rozměr.	«**[.. x .. mm]**, s periferním sycením, uvnitř plyn **[není/je]** kolekce.»	*Rozhodnutí o drenáži se činí podle velikosti, obsahu a vlastností stěny.*

SKUPINA 5

Závěr

8 chyb · Napsáno → Správně → Důvod

Č.	ZAPSÁNO	SPRÁVNĚ	DŮVOD
31	Závěr je kopií Nálezů.	V Závěru uvádějte pouze významné nálezy a jejich interpretaci v pořadí dle důležitosti.	*Oddíl Závěr je shrnutím a interpretací nálezů; pouhé zkopírování ukazuje absenci interpretace.*
32	Závěr neodpovídá na klinickou otázku.	První věta odpovídá na klinickou otázku: «Nebyly zjištěny známky svědčící pro akutní apendicitidu.»	*Indikující lékař hledá odpověď na svou otázku v první větě.*
33	Incidentální nález na prvním místě, urgentní nález na konci.	Urgentní nález je vždy na prvním místě; incidentální nálezy až na samém konci.	*Čtenář většinou čte pouze první řádek.*
34	«Doporučena klinická korelace» (v každém popisu, bezdůvodně).	Napište, s čím a proč korelovat: „Doporučena korelace s laboratorními zánětlivými markery.“	*Neodůvodněné doporučení korelace nenese žádnou informaci a snižuje důvěryhodnost popisu.*
35	Dlouhý a vyhýbavý diferenciálně diagnostický seznam.	Nejprve nejpravděpodobnější diagnóza, poté nanejvýš dvě až tři reálné diferenciální diagnózy.	*Desetipoložkový seznam klinikovi směr neudá; vodítkem je pořadí pravděpodobnosti.*
36	«Malignitu nelze vyloučit» (bezdůvodně).	Uveďte nálezy svědčící pro nebo proti malignitě a doporučený další krok.	*Neodůvodněné „nelze vyloučit“ vyvolává zbytečné obavy a řetězec dalších vyšetření.*
37	Nejasná míra jistoty: „Pneumonie?“	«Odpovídá pneumonii» / «svědčí pro pneumonii» / «může jít o pneumonii» — vyberte jedno z toho.	*Otazník nepatří do jazyka popisu; míra jistoty se vyjadřuje standardními formulacemi.*
38	V Závěru chybí změna oproti předchozímu vyšetření.	«Oproti předchozímu vyšetření [v .. lézi] regrese.»	*U kontrolního vyšetření se klinické rozhodnutí opírá o dynamiku změn.*

SKUPINA 6

Doporučení

4 chyby · Napsáno → Správně → Důvod

Č.	ZAPSÁNO	SPRÁVNĚ	DŮVOD
39	«Doporučeno doplňující vyšetření.»	«K bližší charakterizaci doporučeno MR mozku s kontrastem.»	*Pokud není uvedeno, jaké vyšetření a proč, doporučení nelze uplatnit.*
40	Ke každému nálezu bylo přidáno doporučení ke sledování.	Specifické doporučení pouze pro nálezy, které mění klinické rozhodování.	*Zbytečné doporučení znamená zbytečné vyšetření, náklady a úzkost pacienta.*
41	Byl uveden nejistý interval sledování.	«Nutnost sledování by měla být stanovena ve spolupráci s ošetřujícím týmem podle platných doporučení.» — nebo se zeptejte svého školitele.	*Nesprávný interval může pacientovi uškodit; pokud si číslem nejste jisti, nepište ho.*
42	Uvedeno doporučení léčby: „Měla by být nasazena antibiotika.“	«Může odpovídat pneumonii.»	*Rozhodnutí o léčbě náleží klinickému týmu; radiologický popis poskytuje diagnostické informace.*

SKUPINA 7

Urgentní nález a hlášení

4 chyby · Napsáno → Správně → Důvod

Č.	ZAPSÁNO	SPRÁVNĚ	DŮVOD
43	Urgentní nález je v popisu uveden, ale nebyl nahlášen.	Oznamte telefonicky a zaznamenejte do popisu: „Klinickému týmu **[hodina]** byl hlášen v».	*Doba do přečtení popisu může být pro pacienta kritická.*
44	Hlášení proběhlo, ale v popisu chybí.	« **[Čas]** v **[jednotka]** bylo telefonicky nahlášeno sloužícímu lékaři.»	*Nezaznamenané hlášení může být z medicínsko-právního hlediska považováno za neprovedené.*
45	Záznam o hlášení: „sděleno lékaři“.	Komu (funkce a oddělení), v kolik hodin, jakým způsobem a zda proběhlo zpětné přečtení.	*Nejasný záznam znemožňuje ověření hlášení.*
46	Urgentní nález je uprostřed závěru.	Urgentní nález je první větou závěru.	*Klinik, který čte zběžně, se může zastavit hned na prvním řádku.*

SKUPINA 8

Formální úprava a před podpisem

4 chyby · Napsáno → Správně → Důvod

Č.	ZAPSÁNO	SPRÁVNĚ	DŮVOD
47	V popisu zůstaly hranaté závorky nebo text šablony.	Před podpisem [ ] a značky «...» se vyhledají a smažou.	*Nevymazaný text šablony ukazuje, že popis byl odeslán bez přečtení.*
48	Nesoulad ve jménu pacienta, datu vyšetření nebo žádance.	Identita pacienta, datum a typ vyšetření se zkontrolují vůči popisu.	*Popis patřící nesprávnému pacientovi patří k nejzávažnějším chybám při popisování.*
49	Použity zkratky bez vysvětlení (nezažité zkratky).	Méně obvyklou zkratku při prvním použití rozepište celým slovem.	*Popis se nepíše pouze pro radiology, ale pro všechny kliniky.*
50	Chyba při diktování nebo překlep: „vlevo“ místo „vpravo“, „hypo“ místo „hyper“.	Před podpisem si popis jednou přečtěte od začátku do konce.	*Chyba v jediném písmenu může obrátit význam nálezu.*

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Nyní otevřete Bonus 3 · Popis podle klinické otázky: 30 klinických otázek. Významná část chyb vzniká tím, že popis neodpovídá na klinickou otázku; podívejte se, na co musí popis bezpodmínečně odpovědět u 30 nejčastějších otázek.

Pro správné formulace vět **Bonus 1 · Databanka 200 závěrů popisu**se můžete vrátit.